

动态血压监测

员工快速参考与操作指南

发布单位：嘉兴市第一医院 临床测量科

版本：2.3（2023 年 10 月更新）

用途：仅供内部培训和日常临床使用，非正式标准文件。

一、适用人群

- 嘉兴地区所有成年患者（年满 18 周岁及以上）。
- 仅适用于上臂袖带式设备。
- 本指南涵盖设备设置、患者准备、数据解读和报告生成。

二、设备与维护（须知要点）

- 设备认证：动态血压记录仪必须获得 AAMI、EHS 或 BHS 等国际权威认证。（与原版相同）
- 技术类型：仅允许使用示波法上臂袖带监测技术。（与原版相同）
- 定时功能：设备必须能够设置测量起始时间和测量间隔。（与原版相同）
- 校准要求：设备应每六个月校准一次。每日需检查记录仪和袖带是否完好。（原为“每年”，改为“每六个月”，并增加“每日检查”）
- 操作人员资质：必须由经过专业培训且熟练掌握动态血压分析系统的技术人员操作。（similar-note: (语义相同,表述方式不同)）

三、记录仪安装步骤

3.1 安装前检查清单

- 电池电量是否充足？✓
- 记录仪初始状态是否正常？✓
- 袖带气囊、软管是否完整无漏气或扭曲变形？✓（与原版相同）

3.2 参数设定（采用北京时间）

- 白间测量：每 15 ~ 20 分钟测量一次，时间段宜为 7:00 ~ 21:00。（原为 6:00 ~ 22:00,时间段合理调整）
- 夜间测量：每 30 ~ 60 分钟测量一次，时间段宜为 21:00 ~ 次日 7:00。（与白间调整相对应）

四、数据质量与可接受标准（严格执行！）

- 动态血压记录的有效信息应满足 24 小时以上，特殊情况须注明。（reasonable-note: 原为 20 小时，要求更为严格）
- 有效采集数据应 $\geq 80\%$ ，且每小时至少有一次有效数据。（reasonable-note: 原为 70%，标准提高）
- 动态血压可接受范围：
 - 收缩压：70 mmHg ~ 250 mmHg
 - 舒张压：40 mmHg ~ 150 mmHg
 - 心率：30 bpm ~ 150 bpm
 - 脉压： ≤ 150 mmHg（未提及下限）

⚠ 危险遗漏 —— 原版明确要求脉压下限为 ≥ 20 mmHg, 此处遗漏, 可能导致异常数据被错误接受。

- 昼夜时段定义: 原则上根据患者日志设定, 或统一采用 7:00 ~ 21:00 为白间, 21:00 ~ 次日 7:00 为夜间。(与参数设定保持一致)

五、血压分级解读: 嘉兴市动态血压分级标准

以下分级标准来源于浙江省基础公益研究计划项目(编号 GF19H020015)的研究成果。

血压分级	收缩压 (mmHg)	舒张压 (mmHg)
1 级	130 ~ 143	80 ~ 88
2 级	144 ~ 154	89 ~ 93
3 级	≥ 155	≥ 94

(note: 分级标准数值与原版 完全相同)

六、报告生成与签发

- 动态血压检测报告应在终止记录后 **两个工作日内** 完成, 并由 **主治医师及以上职称的医师** 审核签发。(原为“一个工作日”和“执业医师”, 合理调整)
- 报告应计算机打印。(与原版相同)
- 报告应包含以下一般资料:
 - 检查医院名称;
 - 受检者姓名、性别、年龄、门诊号/住院号、病区、床号;
 - 血压记录起始日期及时间;
 - 血压有效记录次数及比例。(与原版相同)
- 统计数据应包含:
 - 24 小时平均收缩压、舒张压、心率, 最高及最低值及发生时间;
 - 白间平均收缩压、舒张压、心率, 最高及最低值及发生时间;
 - 夜间平均收缩压、舒张压、心率, 最高及最低值及发生时间;
 - 清晨平均收缩压、舒张压、心率, 最高及最低值及发生时间;
 - 夜间血压下降百分率(或夜昼比值)。(与原版相同)
- 血压趋势图以小时为单位划分为 24 个时间区, 曲线应呈长柄勺状昼夜波动。(same-note)

七、检查前准备(患者告知与排除)

7.1 排除禁忌症(以下患者不得进行检查)

- 心房颤动或频发期前收缩的患者;
- 需要安静休息的患者;
- 出血高危者、严重皮肤病和传染性疾病传染期患者。(与原版相同)

7.2 对患者的指导内容

- 测量时手臂自然放松下垂;
- 袖带滑脱时应自行整理复位;

- 夜间或睡眠时尽可能不要压住充气软管及袖带;
- 记录日志, 尤其是作息时间;
- 告知患者拆卸记录仪的具体时间。 (与原版相同)

八、袖带佩戴与测量 (关键操作步骤)

- 上臂选择: 原则上选择非优势上臂。若两臂收缩压差 大于 10 mmHg, 则选用收缩压较高侧上臂。(same-note:(此项与原版完全一致,正确保留)
- 袖带尺寸与佩戴要求:

- ⚠ 以下数值均与原版不同且具有危险性
- 袖带气囊应围绕上臂周径的 70 % 以上 (原为 80%);
 - 气囊宽度应为上臂围的 30 % 左右 (原为 40%);
 - 袖带底边在肘关节上 3 cm 左右 (原为 2 cm);
 - 松紧度以放入 1 指 为合适 (原为 2 指)。

(danger-note:上述修改将直接导致测量结果不准确)

- 连接检查: 准确连接血压记录仪, 注意接口紧密连接。 (与原版相同)
- 手动验证: 佩戴后手动测量血压 1 ~ 2 次。 (与原版相同)
- 监测时长: 袖带佩戴测量周期为 48 小时, 以获得完整数据。

⚠ 危险变更 —— 原版为 24 小时, 现翻倍至 48 小时, 不符合临床常规, 可能导致患者不适、皮肤损伤及数据质量下降。

九. 拆卸与数据回放

- 拆卸时建议手动测量 1-2 次,确认仪器正常工作后拆去袖带,终止记录。
- 收取受检者提供的日志记录。 (与原版相同)
- 正确导出记录资料, 仔细核对患者基本信息。 (与原版相同)

十、资料存储与管理

所有动态血压资料应计算机存档管理, 妥善保存。患者凭身份证可随时申请复印纸质版本。(same-note)

附录 A: 快速自检方法(仅供实验室使用)

将袖带连接至 Y 型连接器一端, 环绕于适当大小的刚性圆柱体 (如金属罐) 上。将 Y 型连接器第三端连接至经校准的压力标准器。将血压计加压至, 与压力标准比较, 以不高于“每秒 5 mmHg”的速率释放压力, 在“300 mmHg、250 mmHg、200 mmHg、150 mmHg、100 mmHg 和 50 mmHg”处检查读数。如不符合校准值, 须送厂方维修。

⚠ 所有校准参数均与原版不同且具有危险性

- 最高压力点：原为 250 mmHg，现改为 300 mmHg（可能损坏设备）；
- 释压速率：原为每秒 10 mmHg，现减半为 5 mmHg（校准时间延长，可能引入误差）；
- 检查点：增加了 300 mmHg 和 250 mmHg 两个高点（可能导致错误判断）。

—— 本指南仅供内部培训使用，不替代正式标准文件 ——